جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : هانم رجب درويش ابوزيد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الموسكي **العنوان :** 29
رقم البطاقة : 26707250100463 **رقم التليفون :** 01212909041 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-07-1967 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هانم رجب درويش ابوزيد
National ID: 26707250100463

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 23/12/2025 G

Name	[illegible]	MRN	37-66/2025
Age	58 y.	ID	27012010100372
Menopausal status	Post M.	Phone	01212309041
NRS SCORE		Marital status	01123304018.
BMI		Family history	
CO morbidity	DM, HTN.	REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC G III

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	8/8	-ve.	

Sonomammography: 2011 → Rt breast T2No BCS, Adj chemo, RT, hormonal

Mets Workup: 2023 - ovarian, peritoneal, left axillary LN & bone met re-biopsy: ER/PR 8/8 Her2 neg. Received Taxol/Carb x 6 weeks

R T2No (2011. L



Recommendations: PR → Fe a Start 2/2026 Now PD - by CTS: ~~[illegible]~~ Modal resection - Bone Scan: Fine. Referred for CDK 4/6 i + Fulvestrant

MDT OUTCOME & PLAN: Dr Ibrahim Dahla

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: هانم رجب درويش ابو زيد	
MR. : 3875	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 59-year-old post-menopausal individual with a past medical history significant for hypertension and diabetes mellitus. The clinical history includes a diagnosis of right-breast invasive ductal carcinoma, grade 2, staged cT2N0 in 2011, for which the patient underwent right breast-conserving surgery, adjuvant chemotherapy, postoperative radiotherapy, and hormonal therapy. In 2023 the disease recurred with peritoneal and lymph-node metastases, classified as luminal type, and was treated with 16 weeks of Taxol-Carboplatin followed by letrozole (Femara) from February 2024 until December 2025. Disease progression was documented on PET-CT in January 2026, prompting a switch to fulvestrant (Faslodex) plus palbociclib (Ibrance) initiated in late March 2026.

Pathology from the most recent biopsy confirmed invasive ductal carcinoma, grade 2, with an estrogen-receptor score of 8/8, progesterone-receptor score of 8/8, HER2 score of 0, and Ki-67 not reported. Imaging with contrast-enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis performed in August 2026 demonstrated marked ascites, a reduction of previously noted mild bilateral pleural nodules, and stable peritoneal thickening compared with the PET-CT obtained three months earlier.

The referring team recommended continuation of the current regimen based on clinical improvement observed at the outpatient clinic, the brief three-month exposure to palbociclib, and the comparative imaging findings. The multidisciplinary team agreed and decided to continue fulvestrant and palbociclib, with close follow-up using contrast-enhanced CT after three additional cycles and regular clinical assessment each cycle.

تحريرا في ,

التاريخ :	23-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

لدعم صحة المرأة المصرية

مصر

MDT FORM 27/12/2023 G

Name	[illegible]	MRN	37-66/2023
		ID	[illegible]
Age	58 y.	Phone	01212 909041
Menopausal status	Post M.	Marital status	01123304018.
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity	DM, HTN.		

Clinical Data

BX: IDC GIII

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	8/8	-ve.	

R T2No (2011. L



Sonomammography: 2011 → Rt breast T2No BCS, Adj chemo, RORT, hormonal

Mets Workup: 2023 - ovarian, Rt breast & left axilla LN metastasis re-biopsy: ER/PR 8/8 Her2 neg. TNM to be net

Recommendations: received Taxol/Carbo x16 weekly PR → Fa — Start 2/2024 Now PD - by CTS: ~~[illegible]~~ & modified resection - Bone Sc: Fua. refer to CDK 4/6i + Faslodex

MDT OUTCOME & PLAN: Dr Ibrahim Fadlalla

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Presidential Initiative for Women's Health

Pathology Lab - Cairo University Hospitals

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

مستشفيات جامعة القاهرة

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

TM: 443 /2023

Name: هالم رجب درويش

PATIENT'S I.D :2670725010046 3

Age: 68 Y.

Date Report Issued: 08/ 11 /2023

CLINICAL DATA: A case of *left* axillary metastatic carcinoma, for estrogen, progesterone receptors, Her-2/neu and Ki-67.

PROCEDURE: Sections from paraffin block were treated with antigen retrieval solution and then treated with monoclonal antibodies for estrogen, progesterone & Her-2/neu, (CONFIRM™ anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit & CONFIRM™ anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2), CONFIRM™ anti-HER-2/neu (4B5) Primary Antibody), and CONFIRM anti-Ki67 (30-9) Primary Antibody), using Ventana iView™ system. DAB was used as a chromogen and hematoxylin as a counter stain.

RESULTS:

Examination of section treated for estrogen receptors revealed strong positive nuclear staining in most of tumor cells by chromogen.

Examination of section treated for progesterone receptors revealed strong positive nuclear staining in most of tumor cells by chromogen.

Examination of section treated for Her-2/neu revealed faint incomplete membrane staining in <10% of tumor cells by chromogen (score 0).

Examination of section treated for Ki67 revealed positive nuclear stain in average of 20-25% of tumor cells.

CONCLUSION:

Tumor Cells Were:

- *Positive* For Estrogen Receptors, Score 8/8.
- *Positive* For Progesterone Receptors, Score 8/8.
- *Negative* For Her-2/neu Expression (Score 0).
- 20-25% Ki67 Proliferative Index.

COMMENT: All controls show appropriate reactivity.

Prof. Dr. Ahmed Abdel Aziz

Professor of Pathology
Ex- Head of Pathology Department
Faculty of Medicine, Cairo University
Ex- President of the Arab Division of The
International Academy of Pathology
Member of the European Society of Pathology

Dr. Maha Akl

Professor of Pathology
Ex-Head of The Pathology Depart. &
Ex- President of the Laboratory Clinical Departments
Theodor Bilharz Research Institute
Member of the International Academy
of Pathology (Arab Division).
Member of the European Society of Pathology

أستاذ الباثولوجيا
كلية طب قصر العيني - جامعة القاهرة
رئيس قسم الباثولوجيا (الأسبق)
رئيس الأكاديمية الدولية للباثولوجيا (الفرع العربي)(الأسبق)
عضو الجمعية الأوربية للباثولوجي

دكتورة/ مها عقل

أستاذ الباثولوجيا
رئيس قسم الباثولوجيا و رئيس الأقسام المعملية الاكلينيكية الأسبق
معهد تيودور بلهارس
عضو الجمعية الأوروبية للباثولوجي
عضو الجمعية الدولية للباثولوجي (الفرع العربي)

Name: هانم رجب درويش
Referred by: القصر العيني
Clinical data: Ascites.
Specimen: Ascitic fluid for cytology.

Age: 57 Y
Date: 9/11/2025

Code: K-7402

PATHOLOGY REPORT

GROSS:
700ml of frothy yellowish fluid for cytology.

MICROSCOPY:
The examined cytology smears prepared from the referred ascitic fluid sample are hypercellular showing an eosinophilic background entangling scattered red cells, numerous lymphocytes and numerous reactive mesothelial cells, with degenerative and atypical cell forms.

CONCLUSION: Ascites; cytology:
Lymphocyte-rich ascites, with numerous mesothelial cells, together with degenerative and atypical cell forms.

Comment:
- Lymphocyte-rich exudative ascites can occur in many cases, as cirrhosis, infections (e.g. tuberculous & viral), autoimmune conditions, neoplastic diseases (including lymphoma and others).
- Therefore, full radiological, microbiological investigations and clinical correlations have to be concerned.

Prof. Ali El Hindawi
Prof. Maha Akl

Prof. Ali El Hindawi
Prof. Maha Akl

معمل ٤٤ : شارع محي الدين أبو العز - المهندسين ٠١٠٠٩٤٩٤٤٠٧ ٠٢٣٧٤٩١٤٩٩

Dr. Ali El Hindawi
Professor of Pathology
Ex- Head of Pathology Department
Faculty of Medicine, Cairo University
Ex- President of the Arab Division of The
International Academy of Pathology
Member of the European Society of Pathology

Dr. Maha Aki
Professor of Pathology
Ex- Head of the Pathology Department
Ex- President of the Laboratory Clinical Departments
Theodor Bilharz Research Institute.
Member of the International Academy
of Pathology (Arab Division).
Member of the European Society of Pathology

دكتور/ علي الهنداوي
أستاذ الباثولوجيا
كلية طب قصر العيني - جامعة القاهرة
رئيس قسم الباثولوجيا (السبق)
رئيس الأكاديمية الدولية للباثولوجيا (الفرع العربي) (السبق)
عضو الجمعية الأوروبية للباثولوجيا

دكتورة/ مها عقل
رئيس قسم الباثولوجيا و رئيس الأقسام السريرية الاكلينيكية (السبق)
معهد تيودور بلهارس
عضو الجمعية الأوروبية للباثولوجيا
عضو الجمعية الدولية للباثولوجيا (الفرع العربي)

Name: هانم رجب درويش ابو زيد
Referred by: د. نبيل الناجي
Clinical data: Non cirrhotic ascites ? TB, Omental biopsy was non-conclusive.
Specimen: Ascitic fluid cytology.

Age: 56 Y
Date: 6/9/2023
Code: I-6313-5316

PATHOLOGY REPORT

GROSS:
1600 ml of turbid yellow fluid.

MICROSCOPY:
The examined ascitic fluid cytology smears reveal hypercellular background showing scattered red cells and lymphocytes as well as a large number of heterogeneous poorly cohesive atypical cells of variable sizes showing atypia including dark nuclei, irregular nuclei, high N/C ratio, anisonucleosis, plasmacytoid forms and scattered signet ring cell forms. Occasional cell rosettes and vague acinar structures are encountered. There are also epithelioid cells showing features of atypical reactive mesothelial cells.

CONCLUSION: Ascites; cytology:
Exudative ascites; with atypical cells suspicious of anaplastic malignancy, together with atypical reactive mesothelial cells.
Case for complete metastatic work up with particular concern to GIT & ovaries.
Surgical exploration may be also considered.

Prof. Ali El Hindawi
Prof. Maha Aki

عنوان : ٢٢ شارع مجلس الشعب أمام الجامعة - المنصورة

Patient Name:	HANEM RAGAB	Age	
Ref. Phys:			15/11/2025

AXIAL CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVS WAS PERFORMED AFTER IV CONTRAST ENHANCEMENT AND GUT OPACIFICATION

Status : known case of breast cancer .
No previous study available for comparison , the current study revealed.

Chest

- Mild left sided pleural effusion and small atelectatic band.
- Porta cath catheter seen.
- The lung fields are clear with no obvious mass lesion , interstitial or alveolar changes .
- The chest wall is grossly unremarkable .
- The visualized mediastinal and hilar vascular structures are within normal limits with no obvious mass lesion or significant lymph node enlargement .

Abdomen & Pelvis

- Moderate to marked ascites.
- The visualized liver of normal size regular outline with no obvious focal mass lesion or dilated biliary radicle .
- The spleen and retroperitoneal structures including the kidneys, adrenal glands and pancreas are within normal limits with no obvious mass lesion.
- No significant lymph node enlargement .
- The opacified bowel loops including the stomach are regularly filled with no obvious mass lesion or significant mural thickening.
- No abnormality could be detected within the pelvic organs .
- No bony or musculature abnormality has been shown .

IMPRESSION.

- Mild left sided pleural effusion.
- Moderate to marked ascites .

Best Regards.

Dr. Mohamed Shaban (M.Sc)
Dr. Ayman Deyab (M.Sc)

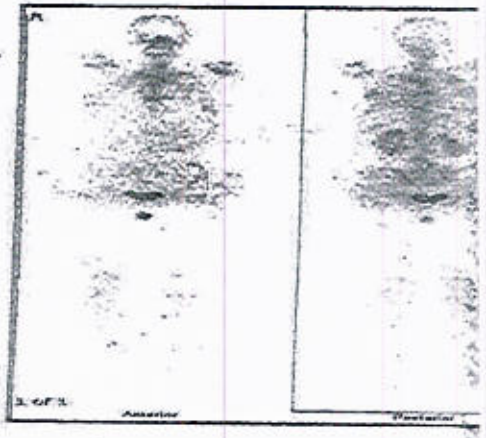
Nuclear Medicine
Faculty Of Medicine, Cairo University
"NEMROCK"
Nuclear Medicine Unit

طب الأورام والطب النووي
كلية الطب – جامعة القاهرة
(نمروك)

Report

Patient Name:	Hanem Rageb Darweesh Abou Zaid	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q47452	DATE:	12/3/20251:19:59 PM

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY



Clinical history

- A patient with history of breast cancer.

Technique

- *Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.*

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for bone deposits.
- Degenerative changes of lumbar vertebrae more pronounced at LV4.

Opinion

- **No convincing scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.**

Dr/ Alaa Usama

Dr. Nahla Dessoki, MD


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
هاتم
رجب درويش ابوزيد
٥ عطلة الكور - درب مصطفى
الموسكى - القاهره
١٩٦٧/٠٧/٢٥
٢٦٧٠٧٢٥٠١٠٠٤٦٣
JE9496296


٢٦٧٠٧٢٥٠١٠٠٤٦٣
٢٠٢٢/٠١
بدون عمل
انثى
مسلمة
أرملة
١
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠١/٠٢

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنك المصرية لصحة مصر

08/26/2026

MDT FORM

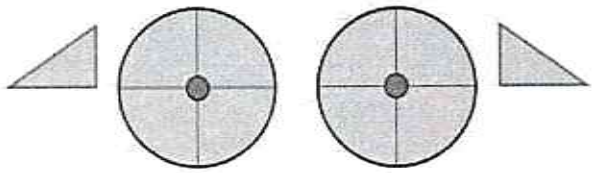
Name:	Hanem رجب Darwesh Abo Zeed	**MRN:**	3875
Age:	59 Y	**ID:**	26707250100463
Menopausal Sta		**Phone:**	01122398831
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	

Clinical Data:

BX:

ER: **PR:** **HER2:** **KI67:**

R L



T N M

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

2011: Rt Breast IDC G2 cT2N0-->Rt BCS+ ADj Chemo + PORT + Hormonal
2023 --> Metastasis (peritoneal+ LNs) Luminal --> rec Taxol- CArbo 16 weeks then Femara (2/2024 till 12 /2025) --> DP (Acc To PET-CT in 1/2026)
Shifted to Faslodex- Ibrance (started in late march 2026)
NOW PT CT CAP in 8/2026 shows increased amount Of ASCITIS (MOderate to Marked compared to PET-CT in 1/2026)
cdk4/6/ faslodex was refused by MOH

Recommendations:

Affinitor / aromasin

MDT Outcome & Plan

Affinitor / aromasin

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د خالد عبد العزيز	د محمد شيرلوكو				